

SOMMAIRE

Slogan 2026 -----	2
Code de bonne conduite -----	3
Liste des Abréviation-----	4
Etude du milieu-----	6
Hygiène et assainissement-----	15
Soins de Santé Primaires /IEC/CCSC /Plaidoyer /Technique d'animation de groupe--	33
Soins de Santé Primaires-----	34
IEC/CCSC -----	41
Plaidoyer -----	47
Technique d'animation de groupe-----	50

SLOGAN POUR L'ANNEE ACADEMIQUE

2025/2026

**« EXCELLENCE AU
QUOTIDIEN, MON
ENGAGEMENT »**

CODE DE CONDUITE

Je suis étudiant de l'INFAS

Je m'engage à **BIEN FAIRE TOUT CE QUE JE DOIS FAIRE**

Je m'oblige à un comportement **CITOYEN, HONNETE et DIGNE**

C'est pourquoi, **JE NE DOIS POINT :**

- ✚ Manquer les cours en classe et en ligne.
- ✚ Tricher lors des compositions et examens pendant ma formation.
- ✚ Négliger les stages.
- ✚ Manquer les compositions et les corrections en classe et en ligne.
- ✚ Manquer de respect à mes enseignants ou encadreurs à l'école comme en stage.
- ✚ Participer à toute action pouvant perturber ou retarder ma formation.
- ✚ Voler les objets en classe ou en stage.
- ✚ Faillir à aucun point de la charte de l'étudiant que j'ai signée dès mon entrée à l'INFAS.
- ✚ Manquer aux dispositions disciplinaires de l'INFAS sur les terrains de stage.

Je m'expose aux sanctions disciplinaires qui s'imposent si je faillis à ces
Engagements.

LISTE DES ABBREVIATION

BCG :	Bacille de Calmette et Guérin
CCSC :	Communication pour le Changement Social du Comportement
CHS	Centre Hospitalier Spécialisé
CMU	Couverture Maladie Universelle
DCPEV	Direction de la Coordination du Programme Elargi de Vaccination
DEPEV	Direction Exécutive du Programme Elargi de Vaccination
DN-HepB	Dose Naissance de L'Hépatite de Type B
EPHN	Etablissement Public Hospitalier National
EPHD	Etablissement Public Hospitalier Départemental
EPHR	Etablissement Public Hospitalier Régional
ESPC	Etablissement Sanitaire de Premier Contact
FAR	Femme en Âge de Reproduction
HPV 1	Human Papilloma Virus 1ère dose
HPV 2	Human Papilloma Virus 2ème dose
HPV 3	Human Papilloma Virus 3ème dose
HTA	Hypertension Artérielle
IDE	Infirmier Diplômé d'Etat
M	Médecin
Men A	Méningite de type A
MSHP-CMU	Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PEV	Programme Elargi de Vaccination
RDV	Rendez-vous

RR1	Rougeole/Rubéole 1ère dose
RR2	Rougeole/Rubéole 1ère dose
SF	Sage-Femme
SIDA	Syndrome Immuno- déficience Acquise
SR/PF	Santé de la Reproduction/ Planification familiale
TB	Tuberculose
Td 1	Tétanos Diphtérie 1ère dose
Td 2	Tétanos Diphtérie 2ème dose
Td 3	Tétanos Diphtérie 3ème dose
Td 4	Tétanos Diphtérie 4ème dose
Td 5	Tétanos Diphtérie 5ème dose
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VAA	Vaccin Anti Amaril
VAP 1	Vaccin Contre le Paludisme 1ère dose
VAP 2	Vaccin Contre le Paludisme 2ème dose
VAP 3	Vaccin Contre le Paludisme 3ème dose
VAP 4	Vaccin Contre le Paludisme 4ème dose
VIH	Virus Immunodéficience Humaine
VPI1	Vaccin Polio Inactivé 1ère dose
VPI1	Vaccin Polio Inactivé 2ème dose
VPO 0	Vaccin polio Orale 1ère dose
VPO 1	Vaccin polio Orale 2ème dose
VPO 2	Vaccin polio Orale 3ème dose
VPO 3	Vaccin polio Orale 4ème dose

ETUDE DU MILIEU OU MONOGRAPHIE

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de pouvoir mener sans difficulté une étude du milieu ou monographie.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir les termes : District sanitaire, étude du milieu, aire sanitaire, bassin de desserte, stratégie, stratégie fixe, stratégie avancée, stratégie mobile.
- 2) Citer les trois groupes de facteurs du milieu pouvant agir sur la santé tout en donnant deux exemples de chaque groupe.
- 3) Citer trois avantages d'une étude du milieu.
- 4) Décrire les éléments entant dans l'élaboration d'une étude du milieu.

INTRODUCTION

La rencontre des hommes dans leur milieu de vie, la recherche des facteurs du milieu pouvant influencer positivement ou négativement leur existence, la compréhension de ces facteurs sont les préalables à toute action sanitaire et sociale dans ce milieu de vie.

Dans ce cas, les attitudes à développer par le personnel de santé pour mener une bonne étude du milieu sont l'**observation** et le **dialogue**. Observer et dialoguer qui consistent à :

- Regarder, centrer son intérêt sur des points précis du milieu ;
- Orienter l'entretien vers les désirs de changement de la population ;
- Exploiter les informations données par les populations ;
- Établir les priorités permettant de définir les objectifs d'action ;
- Apprendre et comprendre le mode de vie et de pensée de la communauté, l'amener à se comprendre elle-même, à découvrir les possibilités d'amélioration sa condition de vie.

1. DEFINITION DES TERMES

1.1 Etude du milieu ou monographie

C'est la connaissance des hommes et de l'environnement dans lequel ils vivent, des problèmes et des moyens de résolution de ces problèmes qui existent dans ce milieu. (UNICEF, 1992)

1.2 District sanitaire

C'est une unité sanitaire déconcentrée dont la superficie s'étend sur un département administratif et regroupant les structures sanitaires publiques et privées dudit département. Il est placé sous l'autorité d'un médecin-chef ou Directeur Départemental de la Santé (DDS).

1.3 Aire sanitaire

C'est une zone géographique bien définie dont la superficie peut s'étendre au-delà de 15km d'un centre de santé et comprenant un ou plusieurs villages ou quartiers, attribués à une ou plusieurs infrastructures sanitaires (publiques et/ou privées) de base, encore appelées Centre de Santé.

1.4 Bassin de desserte :

C'est la zone de compétence de l'infirmier ou de la sage-femme en milieu rural. Dans le cadre de la stratégie des Soins de Santé primaires, sa superficie s'étend sur un rayon de 0 à 15 km autour d'une structure sanitaire (Dispensaire rural, Maternité rurale, Centre de santé rural).

1.5 Stratégie

C'est un « ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis ». Dans le cadre des activités de santé de soins de santé primaires, il existe 3 types de stratégies

1.5.1 Stratégie fixe.

Il consiste pour le personnel de santé à rester au centre de santé et recevoir les populations des localités situées dans un rayon de moins de 5 km autour dudit centre pour les actes de santé.

1.5.2 Stratégie avancée

Il consiste pour le personnel de santé de quitter le centre de santé et aller vers les populations des localités situées entre 5 km et 15km autour dudit centre pour les actes de santé.

1.5.3 Stratégie mobile

Il consiste pour l'équipe mobile du district de se déplacer vers les populations des localités situées au-delà de 15km des centres de santé pour administrer les actes de santé.

ETUDE DU MILIEU OU MONOGRAPHIE

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de pouvoir mener sans difficulté une étude du milieu ou monographie.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir les termes : District sanitaire, étude du milieu, aire sanitaire, bassin de desserte, stratégie, stratégie fixe, stratégie avancée, stratégie mobile.
- 2) Citer les trois groupes de facteurs du milieu pouvant agir sur la santé tout en donnant deux exemples de chaque groupe.
- 3) Citer trois avantages d'une étude du milieu.
- 4) Décrire les éléments entant dans l'élaboration d'une étude du milieu.

INTRODUCTION

La rencontre des hommes dans leur milieu de vie, la recherche des facteurs du milieu pouvant influencer positivement ou négativement leur existence, la compréhension de ces facteurs sont les préalables à toute action sanitaire et sociale dans ce milieu de vie.

Dans ce cas, les attitudes à développer par le personnel de santé pour mener une bonne étude du milieu sont : l'observation et le dialogue. Observer et dialoguer qui consistent à :

- Regarder, centrer son intérêt sur des points précis du milieu ;
- Orienter l'entretien vers les désirs de changement de la population ;
- Exploiter les informations données par les populations ;
- Établir les priorités permettant de définir les objectifs d'action ;
- Apprendre et comprendre le mode de vie et de pensée de la communauté, l'amener à se comprendre elle-même, à découvrir les possibilités d'amélioration sa condition de vie.

I. DEFINITION DES TERMES

1.1 Etude du milieu ou monographie

C'est la connaissance des hommes et de l'environnement dans lequel ils vivent, des problèmes et des moyens de résolution de ces problèmes qui existent dans ce milieu. (UNICEF, 1992)

1.2 District sanitaire

C'est une unité sanitaire déconcentrée dont la superficie s'étend sur un département administratif et regroupant les structures sanitaires publiques et privées dudit département. Il est placé sous l'autorité d'un médecin-chef ou Directeur Départemental de la Santé (DDS).

1.3 Aire sanitaire

C'est une zone géographique bien définie dont la superficie peut s'étendre au-delà de 15km d'un centre de santé et comprenant un ou plusieurs villages ou quartiers, attribués à une ou plusieurs infrastructures sanitaires (publiques et/ou privées) de base, encore appelées Centre de Santé.

1.4 Bassin de desserte :

C'est la zone de compétence de l'infirmier ou de la sage-femme en milieu rural. Dans le cadre de la stratégie des Soins de Santé primaires, sa superficie s'étend sur un rayon de 0 à 15 km autour d'une structure sanitaire (Dispensaire rural, Maternité rurale, Centre de santé rural).

1.5 Stratégie

C'est un « ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis ». Dans le cadre des activités de santé de soins de santé primaires, il existe 3 types de stratégies

1.5.1 Stratégie fixe.

Il consiste pour le personnel de santé à rester au centre de santé et recevoir les populations des localités situées dans un rayon de moins de 5 km autour dudit centre pour les actes de santé.

1.5.2 Stratégie avancée

Il consiste pour le personnel de santé de quitter le centre de santé et aller vers les populations des localités situées entre 5 km et 15km autour dudit centre pour les actes de santé.

1.5.3 Stratégie mobile

Il consiste pour l'équipe mobile du district de se déplacer vers les populations des localités situées au-delà de 15km des centres de santé pour administrer les actes de santé.

II. GROUPES DE FACTEURS DU MILIEU POUVANT AGIR SUR LA SANTÉ

Selon l'auteur Québécois ALONDE, il existe une diversité de facteurs qui peuvent agir positivement ou négativement sur la santé. Nous les regrouperons en trois grands groupes :

- Les facteurs favorisant la santé ;
- Les facteurs favorisant la maladie ;
- Les facteurs déterminant la maladie.

2.1. Facteurs favorisant la santé.

2.1.1 Les facteurs biologiques

- **Facteurs physiologiques** : absence de troubles métabolique (diabète), apport normal des éléments physiologique (bonne aération) etc.
- **Facteurs psychologiques** : absence de troubles psychiques, environnement affectif satisfaisant durant l'enfance, etc.

2.1.2 Les facteurs de l'environnement physique.

- L'absence de promiscuité ;
- L'absence de pollution de l'eau, de l'air et de sol ;
- L'inexistence d'habitat vétuste.

2.1.3 Les facteurs socio-économiques

- L'exercice d'une activité génératrice de revenu
- Accès à l'éducation
- Baisse du coût des denrées alimentaires

2.1.4 Les facteurs culturels

- Inexistence de tabou impactant la santé
- Absence de discrimination
- Absence de pratiques impactant la santé

2.2 Les facteurs favorisant la maladie.

2.2.1 Les facteurs biologiques

❖ Les facteurs physiologiques

- L'âge (vieillard, enfant, adolescent) ;
- Le sexe (femme, notamment femme enceinte) ;
- L'aspect physique (poids ne correspondant pas à la taille, maigreur).

❖ Les facteurs psychologiques,

- Les soucis ;
- Le stress ;
- La peur.

2.2.2. Les facteurs socio-économiques

❖ Les facteurs économiques

- Le chômage ;
- La cherté du coût de la vie ;
- La pauvreté.

❖ Les facteurs socio-culturels

- L'ignorance ;
- Les coutumes ;
- Les tabous.

2.2.3 Les facteurs environnementaux ou de nuisance

- L'eau polluée ou non potable ;
- Les ordures (ménagères et industrielles) ;
- Les bruits.etc

2.3. Les facteurs déterminant la maladie

- Les microbes ;
- Les parasites.
- Les virus, etc.

III. AVANTAGES D'UNE ETUDE DU MILIEU

L'étude du milieu permet au professionnel de santé :

- d'avoir à coup d'œil sur « le tableau de bord » de la structure sanitaire, toutes les informations nécessaires sur les hommes et leur environnement de vie.
- de connaître les différents problèmes de santé du milieu permettant ainsi d'identifier les thèmes éducationnels et les populations cibles;
- de vivre en parfaite harmonie et en symbiose avec la population ;
- de disposer des données fiables et récentes sur la population ;
- de connaître les composantes de la communauté et son organisation sociale

II. GROUPES DE FACTEURS DU MILIEU POUVANT AGIR SUR LA SANTÉ

Selon l'auteur Québécois ALONDE, il existe une diversité de facteurs qui peuvent agir positivement ou négativement sur la santé. Nous les regrouperons en trois grands groupes :

- Les facteurs favorisant la santé ;
- Les facteurs favorisant la maladie ;
- Les facteurs déterminant la maladie.

2.1. Facteurs favorisant la santé.

2.1.1 Les facteurs biologiques

- **Facteurs physiologiques** : absence de troubles métabolique (diabète), apport normal des éléments physiologique (bonne aération) etc.
- **Facteurs psychologiques** : absence de troubles psychiques, environnement affectif satisfaisant durant l'enfance, etc.

2.1.2 Les facteurs de l'environnement physique.

- L'absence de promiscuité ;
- L'absence de pollution de l'eau, de l'air et de sol ;
- L'inexistence d'habitat vétuste.

2.1.3 Les facteurs socio-économiques

- L'exercice d'une activité génératrice de revenu
- Accès à l'éducation
- Baisse du coût des denrées alimentaires

2.1.4 Les facteurs culturels

- Inexistence de tabou impactant la santé
- Absence de discrimination
- Absence de pratiques impactant la santé

2.2 Les facteurs favorisant la maladie.

2.2.1 Les facteurs biologiques

❖ Les facteurs physiologiques

- L'âge (vieillard, enfant, adolescent) ;
- Le sexe (femme, notamment femme enceinte) ;
- L'aspect physique (poids ne correspondant pas à la taille, maigreur).

❖ Les facteurs psychologiques,

- Les soucis ;
- Le stress ;
- La peur.

2.2.2. Les facteurs socio-économiques

❖ Les facteurs économiques

- Le chômage ;
- La cherté du coût de la vie ;
- La pauvreté.

❖ Les facteurs socio-culturels

- L'ignorance ;
- Les coutumes ;
- Les tabous.

2.2.3 Les facteurs environnementaux ou de nuisance

- L'eau polluée ou non potable ;
- Les ordures (ménagères et industrielles) ;
- Les bruits.etc

2.3. Les facteurs déterminant la maladie

- Les microbes ;
- Les parasites.
- Les virus, etc.

III. AVANTAGES D'UNE ÉTUDE DU MILIEU

L'étude du milieu permet au professionnel de santé :

- d'avoir à coup d'œil sur « le tableau de bord » de la structure sanitaire, toutes les informations nécessaires sur les hommes et leur environnement de vie.
- de connaître les différents problèmes de santé du milieu permettant ainsi d'identifier les thèmes éducationnels et les populations cibles;
- de vivre en parfaite harmonie et en symbiose avec la population ;
- de disposer des données fiables et récentes sur la population ;
- de connaître les composantes de la communauté et son organisation sociale

IV.ELEMENTS ENTRANT DANS L'ELABORATION D'UNE ETUDE DU MILIEU

Pour faire une étude de milieu, certaines informations doivent être recherchées. Ce sont les informations relatives :

1. à la cartographie du centre;
2. à l'identification du centre ;
3. aux ressources humaines ;
4. à la population ;
5. aux cours d'eau et marigots;
6. à l'éducation et à la formation professionnelle ;
7. aux structures sanitaires ;
8. à l'agriculture et à l'alimentation ;
9. aux structures sociales, culturelles et spirituelles ;
10. à la communauté.

4-1. La cartographie du centre : l'activité va consister à dessiner la carte du bassin de desserte. Elle permet de :

- limiter le bassin de desserte. (15km autour du centre);
- représenter les infrastructures socio-économiques et culturelles implantées dans le bassin de desserte (route, marché église, temple , mosquée, etc.)

4-2. Les informations relatives à l'identification du centre

Elles constituent la « carte d'identité » de la structure sanitaire et prend en compte:

- le nom de la localité où est implantée la structure sanitaire ;
- la dénomination de la structure sanitaire (DR, Maternité rurale, CSR, CSU, etc) ;
- le code du centre de santé (auprès du Directeur départemental ou le CSE);
- la date d'ouverture du centre de santé (Auprès de la communauté, du DDS) ;
- la distance séparant la structure sanitaire au district et à la région sanitaire (dans les archives du district sanitaire, de la structure sanitaire ou auprès de la communauté).

4-3. Les informations relatives aux ressources humaines

Ce sont les informations sur les agents de santé et le personnel de soutien exerçant dans la structure sanitaire .Elles peuvent être recherchées dans les archives de la structure sanitaire. Ces informations vont permettre au responsable du centre de soins d'estimer ses besoins en ressources humaines. L'agent de santé doit connaître:

- le nombre de médecins ;
- le nombre d'infirmiers et de sage-femmes spécialistes ;
- le nombre d'infirmiers et de sages-femmes diplômés d'Etat ;
- le nombre de techniciens supérieurs de santé;
- le nombre d'auxiliaires de santé;
- le nombre d'aides soignants ;
- le nombre d'ambulanciers ;
- le nombre d'agents d'entretien, etc.

4-4. Les informations relatives à la population

Elles sont l'ensemble des informations sur la population totale et celle des différents villages de l'aire sanitaire. Elles vont permettre à l'agent de santé de connaître le dénominateur c'est-à-dire les populations cibles.

Elles concernent:

- la population totale actualisée de l'aire sanitaire (CSE);
- Le nombre d'enfants de 0 à 11 mois : 3,5 % de la population totale ;
- Le nombre d'enfants de 0 à 6 mois : 1,45% de la population totale
- Le nombre d'enfants de 0 à 23 mois : 6,82% de la population totale
- Le nombre d'enfants de 12 à 23 mois : 3,32% de la population totale
- Le nombre d'enfants de 1 à 4 ans : 17,32 % de la population totale;
- Le nombre d'enfants de 0 à 5 ans : 20 % de la population totale ;
- Le nombre de FAR: 20 % de la population totale ;
- Le nombre femmes enceintes ou grossesses attendues : 5% de la population totale;
- Le nombre femmes enceintes séropositives : 4,1 % des grossesses attendues
- Le nombre de naissances attendues : 4,7 % de la population totale;
- Le nombre de jeunes filles de 9 ans : 1,86% de la population totale;
- Le nombre d'enfants de 9 mois à 14 ans : 45% de la population totale;

- Le nombre d'habitants vivant dans un rayon de moins 5 km du centre de soins, de 5 à 15 km et à plus de 15 km ;
- le nombre d'enfants de 0 à 11 mois vivant dans un rayon de moins 5 km du centre de soins, de 5 à 15 km et à plus de 15 km ;
- le nombre de femmes enceintes vivant dans un rayon de moins 5 km du centre de soins, de 5 à 15 km et à plus de 15 km ;
- le nombre de villages et campements situés dans un rayon de moins de 5 km de la structure sanitaire, de 5 à 15 km et à plus de 15 km ;

4-5. Les informations relatives au marigots et cours d'eau.

Elles sont l'ensemble des informations sur les cours d'eau et les puits (modernes et traditionnels) de l'aire sanitaire. Elles peuvent permettre d'établir le lien entre les maladies et les eaux de surface qui servent parfois de consommation ou de bain.

L'agent de santé doit connaître :

- le nombre de fleuves, rivières et marigots etc. ;
- le nombre de puits traditionnels (préciser l'emplacement / aux latines).
- le nombre de pompes à motricité humaine (préciser si fonctionnelles ou non) ;
- le mode d'approvisionnement de la population en eau (eau de surface ou eau de captation).
- les moyens de potabilisation de l'eau connues et pratiqués par la communauté ;
- L'eau de consommation de la population (eau courante, pompe, puit, marigot)

4-6. Les informations relatives à l'éducation et à la formation professionnelle.

Elles peuvent permettre à l'agent de santé de planifier les activités promotionnelles, préventives et curatives dans les écoles. Ainsi, il doit repertorier :

- le nombre d'écoles (publiques, privées, confessionnelles) ;
- le nombre d'écoles qui disposent de latrines (préciser celles qui sont fonctionnelles ou non) ;
- le nombre d'écoles professionnelles
- le nombre d'enseignants ;
- le nombre d'élèves (préciser le nombre de filles et de garçons) ;
- le nombre de cantines scolaires (fonctionnelles ou non), etc.

4-7. Les informations sanitaires

Elles permettent à l'agent de santé de repertorier les centres de soins publics et privés.

Il doit connaître :

- le nombre de structures sanitaires privées et publiques ;
- le nombre de cliniques médicales et infirmeries privées ;
- le nombre de pharmacies et de dépôts pharmaceutiques ;
- les maladies rencontrées dans l'aire sanitaire ;
- les maladies endémiques ;
- Les maladies sous surveillance ;
- Les maladies à déclaration obligatoire, etc.

4-8. Les informations relatives à l'agriculture et à l'alimentation

Elles permettent à l'agent de santé de connaître le pouvoir d'achat des populations, d'orienter les messages éducatifs dans le domaine de l'alimentation. Ainsi, il doit connaître :

- les principales cultures pérennes de la localité (café, cacao, coton, etc.) ;
- les principales cultures vivrières. (riz, igname, mil, manioc, etc.) ;
- les principaux aliments de base de la population ;
- les interdits alimentaires de la communauté, etc.

4-9. Les informations d'ordre économique, social, culturel et spirituel

Elles permettent à l'agent de santé de mieux connaître la communauté et son organisation sociale. Il doit savoir :

- les jours de marché (préciser les jours de marché par village si possible) ;
- les noms des différents chefs de village, des chefs de terre, des notables ;
- la hiérarchisation de la communauté (organisation sociale).
- les responsables des groupes cibles (femmes, jeunes, planteurs, etc.)
- les noms des leaders d'opinion si possible ;
- les noms des responsables des associations à base communautaire ;
- les jours de repos ou jours tabou ;
- les principales fêtes culturelles de la localité et les interdits y afférents ;
- les principales religions implantées dans l'aire sanitaire et les noms de leurs responsables.

4-10. Les informations concernant la communauté

Elles permettent à l'agent de santé de connaître les composantes, les structures communautaires, l'itinéraire thérapeutique de la communauté. Il doit repertorier:

- le nombre de cases de santé ;
- le nombre d'agents de santé communautaires (ASC);
- le nombre d'accoucheuses traditionnelles (AT) ;
- le nombre de guérisseurs traditionnels et leurs domaines de compétence si possible ;
- le nombre des comités d'hygiène et le nom des présidents ;
- le nombre de comités locaux de lutte contre le SIDA si possible ;
- le nombre de comités de gestion et leurs différentes compositions.

Cette liste n'est pas exhaustive. Elle peut être étendue sur l'historique du village par exemple et autres d'informations que l'agent de santé pourrait trouver pertinente.

Conclusion

L'exercice de la profession infirmière et sage femme/Maieuticien dans un milieu social donné va au delà de la maîtrise des compétences pratiques. La connaissance des hommes et de l'environnement dans lequel ils vivent est aussi très importante. La réussite des programmes de sensibilisation et d'éducation en dépend. L'étude du milieu est un outil qui permettra aux futures agents de santé d'être efficace.

HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DU MILIEU

GENERALITES

L'hygiène est définie en 1949 par l'OMS comme un « ensemble de mesures (moyens et pratiques) visant à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle est basée essentiellement sur trois actions : le nettoyage et la déterision, la désinfection, la conservation ».

Quant au mot « assainissement », il est également par l'OMS en 1949 comme « un ensemble d'actions visant à améliorer les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d'influer défavorablement sur le bien-être physique, mental ou social des individus ou des communautés ».

Les activités d'hygiène et assainissement sont donc un ensemble d'actions Individuelles ou collectives initiées par une communauté ou menées au sein d'une population pour préserver la santé par la propreté corporelle, dentaire, vestimentaire, alimentaire, de l'habitat... et l'assainissement de son milieu de vie (eau, ordures, excréta, bruits sonores). L'étude sur l'hygiène et l'assainissement embrasse de nombreux domaines. Mais nous parlerons dans le cadre de notre enseignement de cinq domaines que sont :

1. L'approvisionnement en eau potable ;
2. L'hygiène de l'habitat ;
3. L'évacuation et traitement des ordures ménagères, des excréta, des eaux usées et des déchets toxiques et radioactifs
4. La lutte contre les vecteurs, rongeurs et les nuisances sonores.

I-APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Objectif général.

Ce cours vise à permettre à IDE/SF/M de la L1 de connaître les techniques d'approvisionnement des communautés en eau potable.

Objectifs spécifiques.

A la fin du cours, l'étudiant de la L1 doit être capable de :

- 1) Citer les différents types d'eau
- 2) Citer les différents types de pollution
- 3) Citer les différentes maladies liées à l'eau
- 4) Citer les qualités d'une eau potable
- 5) Citer les critères pour le choix d'une source d'approvisionnement en eau potable
- 6) Citer les moyens de captage d'une eau souterraine
- 7) Enumérer les précautions à prendre pour la construction d'un puits traditionnel
- 8) Enumérer les précautions à prendre pour l'aménagement d'un puits traditionnel
- 9) Citer les critères d'aménagement d'une source d'eau.
- 10) Décrire les différentes méthodes de purifications de l'eau à domicile

INTRODUCTION

La vie est quasi impossible sans eau. S'il est nécessaire de pourvoir l'eau en quantité suffisante, il est également requis que cette eau soit saine et pure car elle constitue parfois le véhicule dans un grand nombre de maladies. A ce titre, elle constitue une préoccupation majeure de l'hygiène publique.

I. DIFFERENTS TYPES D'EAUX

De façon générale, l'on distingue :

1.1 Les eaux souterraines

Ce sont les eaux contenues dans le sous-sol et celles qui émergent sous forme de sources. Elles sont couramment utilisées pour la consommation.

1.2 Les eaux de surface

Elles sont constituées par l'eau de pluie récoltée, l'eau des lacs, des lagunes, des marigots des marres, des mers, etc.

II. DIFFERENTES TYPES DE POLLUTIONS DES EAUX

2.1 Les pollutions domestiques

Ce sont les déchets de la vie humaine qui sont déversés dans les rivières, les lacs, les mers, les lagunes par les eaux de ruissellement.

2.2 Les pollutions industrielles

Ce sont les déchets des usines, les eaux de lavage, de refroidissement et de graissage.

2.3 Les pollutions agricoles

Elles sont causées par les engrais, les désinfectants qui contaminent les eaux de rivière et détruisent la vie animale de celles-ci.

2.4 Les pollutions diffuses ou collectives

Ce sont les pollutions provoquées par les détergents, les hydrocarbures et les huiles de vidanges.

III. LES MALADIES LIEES A L'EAU

3.1 Maladies liées à la qualité chimique de l'eau

- Le goitre endémique : manque ou insuffisance d'iode ;
- La carie dentaire : manque ou insuffisance de fluor ;
- Le saturnisme : l'excès de plomb dans l'eau ;
- La fluorose : excès de fluor dans l'eau.

3.2 Maladies liées à la présence de germe

- à Les maladies bactériennes : la dysenterie bacillaire, le choléra, etc.
- Les maladies parasitaires : la dysenterie amibienne, les helminthiases, etc.
- Les maladies virales : la poliomyélite et les hépatites virales.

3.3 Maladies liées au développement de vecteur dans l'eau

- La fièvre jaune ;
- Le paludisme ;
- L'onchocercose, etc. ;

IV. LES QUALITES D'UNE EAU POTABLE

Elles sont la fois physique, chimiques et bactériologiques.

4.1 Les qualités physiques d'une eau potable

- Limpide ;
- Fraîche ;
- Incolore ;
- Inodore ;
- Aérée et ne doit pas avoir une saveur désagréable.

4.2 Les qualités chimiques d'une eau potable

- Une eau potable est dite minéralisée si elle est pauvre en ions de chlore, sulfate, etc.
- Une eau est dite dure lorsqu'elle contient excessivement de magnésium, de calcium, de fluor, de calcaire, de l'iode.

4.3 Les qualités bactériologiques d'une eau potable

L'eau potable ne doit contenir aucun germe pathologique.

V. CRITERES POUR LE CHOIX D'UNE SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

- **La salubrité** : elle doit produire de l'eau indemne d'impureté ;
- **La régularité (débit)** : elle doit produire constamment un volume important d'eau.
- **Le coût** : elle doit être moins coûteuse et produire une eau immédiatement consommable sans traitement.

VI. MOYENS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES

6.1 Les puits

Ils constituent le moyen le plus courant de captage des eaux souterraines. Il existe différents types de puits

6.1.1. Les puits ordinaires

Ce sont des puits creusés manuellement. Leur diamètre dépend des facteurs économiques de chaque individu. Ils comportent un revêtement pour maintenir les parois et empêcher la pénétration des eaux de surface polluées.

6.1.2 Les puits forcés

Ce sont des puits avec un tube perforé de 2 à 10 centimètres que l'on enfonce sous la terre jusqu'à atteindre la nappe aquifère.

6.1.3 Les puits forés

Ce sont des puits obtenus des suites d'un forage. Ils permettent d'extraire une grande quantité d'eau.

6.1.4 Les puits artésiens

Ce sont des puits qui se creusent au lieu même de la source. Ils permettent de capter l'eau de cette source et d'en assurer sa distribution

VII. PRECAUTIONS POUR LA CONSTRUCTION D'UN Puits TRADITIONNEL

- Situer le puits à au moins **15 mètres** de toutes sources de contamination (toilettes, cimetière, latrines, etc.) lorsqu'il est situé sur un terrain plat
- Creuser jusqu'au moins **10 mètres** de profondeur pour en accroître sa capacité et augmenter le rendement
- Placer le puits en amont des sources de contamination lorsqu'il est situé sur un terrain en pente.

VIII. PRECAUTIONS POUR L'AMENAGEMENT D'UN Puits TRADITIONNEL

Le puits doit :

- Avoir une margelle de 0,70 mètres de hauteur pour éviter les chutes des enfants et des animaux ;
- Être entouré d'une aire cimentée d'un rayon de 2 à 3 mètres pour maintenir les abords immédiats du puits propres et drainer facilement les eaux renversées pendant le puisage et les eaux de ruissellement ;
- Avoir un cuvelage d'une hauteur minimale de 3 mètres avec les meilleurs matériaux possibles pour éviter les éboulements ;
- Avoir un périmètre de protection d'au plus 10 mètres de diamètre pour protéger le puits contre les animaux domestiques ;
- Être toujours couvert et muni d'une pompe si possible ou d'un seau accroché à l'entrée du puits et qui sert à puiser.

IX CRITERES POUR L'AMENAGEMENT D'UNE SOURCE D'EAU

- Construction autour de la source d'un périmètre de protection d'environ 20 à 30 mètres de diamètre ;
- Interdiction de placer en amont des latrines, des systèmes d'évacuation des excréta ou des eaux usées à proximité de la source ;
- Éviter de déféquer ou de se laver à proximité de la source.

X. DIFFERENTES METHODES DE PURIFICATION DE L'EAU A DOMICILE

10.1 Méthodes de correction des défauts physiques de l'eau

10.1.1 La turbidité

L'eau trouble peut être corrigée par la décantation, la filtration, la sédimentation.

La saveur et l'odeur

La saveur et l'odeur de l'eau peuvent être améliorées en utilisant du charbon activé en poudre vendu en pharmacie ou le charbon de bois au village.

10.1.2 La température de conservation

Elle est représentée par la température ambiante

10.2 Correction des défauts bactériologiques de l'eau

10.2.1 L'ébullition

Elle consiste à bouillir l'eau pendant au moins **10 à 15 minutes** et la laisser reposer. L'ébullition a pour inconvénient de faire perdre à l'eau les gaz dissouts. Pour cela, il est nécessaire de l'aérer avant sa consommation.

10.2.2 La javellisation ou chloration

Elle consiste à purifier l'eau à l'aide de l'eau de javel. La quantité de javel à utiliser dépend de la nature de l'eau.

- **Si l'eau claire** : Mettre gouttes d'eau de javel pour 10 L d'eau ;
- **Si l'eau trouble** : Ajouter 6 gouttes d'eau de javel pour 10L d'eau.

10.2.3 L'ionisation (iode)

Elle consiste à utiliser de l'iode pour purifier l'eau. Il faut 15 à 20 gouttes.

10.2.4 Utilisation du permanganate

Elle consiste à ajouter de l'hyposulfite de soude à raison d'un comprimé / litre d'eau après 20 minutes de contact.

10.2.5 La filtration

Elle consiste à filtrer l'eau à l'aide de filtre moderne ou artisanal. Elle peut aussi se faire au travers des tissus filtres ou pagnes en zone rurale.

10.3 Correction des défauts chimiques de l'eau

Il s'agit d'équilibrer la composition chimique de l'eau pour la rendre potable.

2-HYGIENE DE L'HABITAT

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de connaître les notions relatives à l'hygiène de l'habitat.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir les termes liés à l'habitat
- 2) Décrire les critères relatifs aux besoins physiologiques, psychologiques, à la protection contre la contagion et à la sécurité.
- 3) Citer les objectifs de l'hygiène du milieu

INTRODUCTION

La notion de l'habitat ne se limite plus seulement au simple concept de logement ou abri qui sert à protéger l'homme contre les diverses agressions. Cette conception s'est désormais élargie et comprend outre l'abri, le milieu dans lequel il est implanté et l'individu qui possède cet habitat.

La relation "santé-habitat" est souvent difficile à établir car les liens qui sont indirects ne sont pas perceptibles.

Chaque pays possède ses critères pour améliorer et mesurer la salubrité de l'habitat, mais un consensus se dégage au niveau de certains critères relatifs aux besoins physiologiques, aux besoins psychologiques, à la protection contre la contagion et aux besoins de sécurité.

I. DEFINITIONS DES NOTIONS LIEES A L'HABITAT

1.1 Habitat

C'est un mode d'organisation de peuplement par l'homme du milieu où il vit

1.2 Habitat humain

C'est un mode d'occupation de l'espace par l'homme à des fins de logement

II. CRITERES RELATIFS AUX BESOINS

2.1 Critères relatifs aux besoins physiologiques

- Une température adéquate pour assurer le confort (21 à 22°C) au niveau des chambres) ;
- Une absence d'humidité ;
- Une aération et une ventilation suffisante, etc.

2.2 Critères relatifs aux besoins psychologiques

- La préservation de l'intimité ;
- L'existence de confort ;
- La possibilité d'assurer l'hygiène du logement et la propreté personnelle, etc.

2.3 Critères relatifs à la protection contre la contagion

- L'approvisionnement en eau potable et en eau courante ;
- L'évacuation des déchets solides et liquides (eaux usées) ;
- La lutte contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles, etc.

2.4 Critères relatifs aux besoins de sécurité

- Le logement doit être construit avec des matériaux appropriés pour éviter son effondrement ;
- Il doit être conçu en tenant compte des mesures de protection contre les incendies et les accidents domestiques ;
- Les portes et fenêtres doivent être solides pour assurer la protection contre les agressions.

III. OBJECTIFS DE L'HYGIENE DU MILIEU

- Prévenir la mortalité prématurée ;
- Prévenir les maladies et les traumatismes ;
- Assurer le bon rendement de l'organisme humain ;
- Assurer le confort.

3-EVACUATION ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES, DES EXCRETA, DES EAUX USEES ET DES DECHETS TOXIQUES ET RADIOACTIFS

Objectif général.

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de connaître le système d'évacuation, de traitement des ordures ménagères, des excréta et de gestion des eaux usées.

Objectifs spécifiques.

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Décrire les étapes du processus d'évacuation des ordures ménagères
- 2) Citer les normes de sécurité d'une décharge
- 3) Décrire les différentes méthodes de traitement des ordures ménagères
- 4) Décrire le mode transmission des maladies par les excréta
- 5) Déterminer les moyens de lutte contre le péril fécal
- 6) Citer les critères d'un bon système d'évacuation des excréta
- 7) Citer les différents systèmes d'évacuation des excréta
- 8) Décrire la gestion des eaux usées en milieu rural et en milieu urbain.

INTRODUCTION

L'évacuation et le traitement insalubres des ordures ménagères, des excréta humains ou d'animaux et des eaux usées pose un problème de santé publique aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Les ordures ménagères et les excréta humains laissés à proximité d'une source d'approvisionnement en eau de consommation peut polluer l'eau de boisson et provoquer des maladies. Pour assurer la protection des populations, L'Etat doit mettre en place une bonne politique de gestion des ordures ménagères, assurer une évacuation correcte des excréta et des eaux usées dans des conditions hygiéniques appropriées.

I. ETAPE DE PROCESSUS D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES

Deux phases interviennent dans le processus d'évacuation des ordures ménagères. Ce sont : le **stockage** et le **ramassage**

1.1 Le stockage : Il peut être familial ou communautaire.

1.1.1 Le stockage familial

Il se fait à domicile avec un récipient muni d'un couvercle ou dans un sachet en plastique qui doit être toujours bien entretenu.

Le stockage communautaire

Il se fait par des installations mises en place pour stocker les ordures ménagères afin d'être ramassées et jetées dans des décharges.

1.2 Le ramassage ou la collecte des ordures ménagères :

Il se fait de porte à porte ou au lieu de stockage communautaire avec des véhicules appropriés

II NORMES DE SECURITE D'UNE DECHARGE COMMUNE

Une décharge commune doit respecter les normes de sécurité suivantes :

- Etre située au moins à 20 mètres de tout habitat ;
- Ne doit pas être située en hauteur ;
- Doit être située au moins à 100 mètres de tout cours d'eau ;
- Doit être entourée d'une clôture.

III. DIFFERENTES MEHODES DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES.

Il se fait par :

3.1 L'incinération

C'est un procédé qui consiste à brûler les ordures ménagères stockées à l'aide d'un incinérateur ou à y mettre le feu dans un endroit choisi à cet effet.

Les inconvénients de ce procédé sont la pollution atmosphérique et les objets en verre et les métaux qui ne brûlent pas.

3.2 Le compostage

Il consiste à mettre les déchets végétaux (feuillage, légumes, etc.) dans un trou et les recouvrir de 2 à 3 cm de terre. Ces déchets se transforment rapidement en composte utilisable comme engrais pour les cultures maraîchères.

IV. MODE DE TRANSMISSION DES MALADIES PAR LES EXCRETAS

L'homme est le réservoir de virus de certaines maladies. Il contamine l'environnement (sol, eau, aliments) lors de l'émission de selles et urines (excréta) exposant ainsi ses semblables aux maladies liées au péril fécal.

V. MOYENS DE LUTTE CONTRE LE PERIL FECAL

Pour lutter contre le péril fécal, l'infirmier, la sage-femme et le maïeuticien doivent dire à la population de :

- Porter des chaussures fermées ;
- Assurer la potabilité de l'eau ;
- Se laver les mains avant de manger et après les selles ;
- Protéger les aliments contre les mouches ;
- Cuire les aliments ou désinfecter ceux qui sont à consommer crus ;
- Traiter les malades atteints de gastro-entérites ;
- Construire et utiliser effectivement des latrines.

VI. CRITERES D'UN BON SYSTEME D'EVACUATION DES EXCRETA

Pour un bon système d'évacuation des excréta, les critères suivants doivent être respectés :

- Le sol superficiel ne doit pas être contaminé par les excréta ;
- L'eau de surface ne doit pas être contaminée par les excréta ;
- Les eaux souterraines ne doivent pas être contaminées ;
- Les excréta ne doivent pas être manipulés (habitudes socioculturelles) ;
- Les excréta ne doivent pas être accessibles aux animaux et aux mouches ;
- Les odeurs et les aspects malpropres doivent être évités ou prévenus ;
- L'installation adoptée doit être très simple et peu coûteux.

VII. DIFFERENTS SYSTEMES D'EVACUATION DES EXCRETA

Il existe deux systèmes d'évacuation des excréta :

- Les systèmes d'évacuation des excréta sans entraînement de matières fécales ;
- Les systèmes d'évacuation des excréta avec entraînement de matières fécales.

7.1 Les systèmes d'évacuation des excréta sans entraînement de matières fécales

Dans ce système, les excréta sont directement déposés dans le sol sec ou humide ou dans l'eau et subissent leur décomposition sans être entraîner.

Cette méthode comprend les types d'installations dont le plus couramment utilisé est le cabinet à fosse ou latrine à fosse.

✓ Le cabinet ou latrine à fosse

Un cabinet à fosse est un dispositif d'évacuation des excréta, creusé à la main.

Il comprend :

- Une fosse d'un diamètre de 90 à 120 cm et de 1,80 à 2,5m de profondeur ;
- Un soubassement (fondation) ;
- Un plancher qui sert à protéger la fosse et à supporter l'utilisateur ;
- Un tertre sert à supporter l'utilisateur et à protéger la fosse des ruissellements ;
- Un abri qui assure l'isolement et protège la fosse et l'utilisateur.

❖ Avantages d'un cabinet ou latrine à fosse. Il permet d'éviter :

- La pollution du sol superficiel ;
- La contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ;
- Les mouches et rongeurs d'accéder aux excréta

Il est de conception simple, d'utilisation et d'entretien facile, peu coûteux et peut durer au moins 10 à 15 ans.

❖ Inconvénients d'un cabinet ou latrine à fosse.

- Dégage des odeurs ;
- Est difficilement utilisable par les enfants.

❖ Conditions d'installation d'un cabinet ou latrine à fosse

L'installation d'un cabinet à fosse doit obéir aux conditions suivantes :

- La construction d'une latrine dans des zones contenant des roches fissurées ou des formations calcaires doit être précédée d'une enquête minutieuse ;
- L'emplacement de la latrine doit être dans un endroit sec, bien drainé et situé au-dessus du niveau de crue.
- La latrine doit être située en aval de toute source d'eau ;
- Elle doit être située au moins à 15m (quinze) mètres de toute source d'eau ;
- Elle doit être située au moins à 6 mètres de tout habitat ;
- La fosse doit avoir au moins 1,5 mètre de profondeur au-dessus de la nappe aquifère.

7.2 Les systèmes d'évacuation des excréta avec entraînement des matières fécales.

Ils sont utilisés dans les localités aux habitations modernes qui comportent des systèmes d'assainissement individuels ou collectifs avec un système d'installation pour recueillir les eaux usées. Ils comprennent :

- La fosse d'aisance ;
- La fosse septique.

7.2.1 La fosse d'aisance

Il s'agit de fosse avec couvercle qui reçoit l'eau brute. Elle a une capacité d'environ 68 litre/mois/personne. Le contenu de la fosse doit être extrait périodiquement. (la vidange se fait environ tous les 6 mois).

7.2.2 La fosse septique

C'est un système mis en place pour évacuer les excréta de façon satisfaisante. Elle comprend

- Un réseau de décontamination étanche et couvert dans lequel les eaux brutes, après plusieurs passages dans les compartiments de la fosse d'aisance sont évacuées
- Une fosse en béton ou en ciment dont les dimensions sont les suivantes :
 - _ Longueur : 2,10 m ;
 - _ Largeur : 1,50 m ;
 - _ Profondeur : 1,50 m.

Attention : Il est formellement interdit de jeter dans les fosses septiques des désinfectants car elles éliminent les germes anaérobies qui sont à la base du fonctionnement de la fosse. Il est aussi interdit d'y verser de l'eau savonneuse et les détergents.

❖ Les avantages de la fosse septique. Il permet d'éviter :

- _ La pollution du sol superficiel ;
- _ La contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ;
- _ Les mouches et les rongeurs d'accéder aux excréta.

❖ Les Inconvénients de la fosse septique

- _ Sa mise en œuvre nécessite une installation d'eau courante ;
- _ Son fonctionnement nécessite l'évacuation et le traitement d'importants volumes d'eau contaminés.

VIII. LA GESTION DES EAUX USEES

Les eaux usées sont les eaux qui proviennent des douches, de la lessive, des cuisines, des abattoirs, des usines. Dans les habitats modernes, les eaux usées empruntent le même circuit que les excréta.

La gestion des eaux usées se fait aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain

8.1 Gestion des eaux usées en milieu rural

L'essentiel des eaux usées en milieu rural proviennent des douches. Il faut donc construire en aval de ces douches des ouvrages comme un puits perdu par exemple pour recueillir ces eaux usées. Ces puits doivent être protégés par des dalles en béton ou en fer soutenues par du bois solide ou du rônier.

8.2 Gestion des eaux usées en milieu urbain

Les eaux usées en milieu urbain sont les eaux résiduelles industrielles et les eaux de ruissellement.

8.2.1 Les eaux résiduelles industrielles

Elles doivent être épurées et traitées avant leur évacuation au niveau de la mer car ces eaux contiennent des cyanures, du mercure qui sont des produits toxiques pouvant contaminer la mer et la faune.

8.2.2 Les eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement qui proviennent des pluies et qui nécessitent la construction de caniveaux pour leur évacuation.

IX TRAITEMENT DES DECHETS TOXIQUES ET RADIOACTIFS

9.1 Le traitement des déchets toxiques

De nombreuses industries surtout les industries métallurgiques créent énormément de déchets qui, s'ils ne sont pas traités, pourraient ainsi polluer les points d'eau. Des lors, ces industries devraient posséder des unités de traitement des déchets avant leur évacuation.

9.2 Le traitement des déchets radioactifs

La gestion des déchets radioactifs est une préoccupation du moment, tant pour les pays industrialisés que ceux des pays en voie de développement car il se pose un problème de traitement et de lieu de dépôt. Les pays développés, producteurs de ces déchets, sont confrontés au traitement correct de ces déchets du fait du coût élevé de ces traitements.

4- LUTTE CONTRE LES VECTEURS, RONGEURS ET LES NUISANCES SONORES

Objectif général.

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de lutter contre les vecteurs, les rongeurs et les nuisances sonores

Objectifs spécifiques.

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Définir un vecteur, un bruit
- 2) Citer les deux modes de transmission des maladies par les vecteurs
- 3) Citer les deux (2) méthodes de lutte contre le moustique
- 4) Citer les méthodes de lutte contre les rongeurs
- 5) Citer les sources de bruit
- 6) Citer les effets du bruit sur la santé

I. DEFINITIONS

1.1 Vecteur :

C'est un arthropode qui transmet des germes pathogènes d'un hôte à un autre (moustiques, mouches tsé-tsé, etc.)

1.2 Bruit

C'est un son indésirable, déplaisant ou agaçant, soit parce qu'il gêne la perception d'un autre son, soit parce qu'il est dommageable pour la santé physique et psychique.

II. MODES DE TRANSMISSION DES MALADIES PAR LE VECTEURS

- La transmission biologique ;
- La transmission mécanique.

2.1 La transmission biologique

L'agent pathogène absorbé par l'insecte (agent vecteur) accomplit un cycle de développement à l'intérieur de celui-ci. Ce n'est que lorsque ce cycle est achevé que le parasite peut être inoculé à un nouvel hôte ou déposé sur sa peau.

L'insecte est donc dit infestant. Cette situation s'observe dans le cas des grandes endémies tels que le paludisme, la filariose (onchocercose) et la trypanosomiase.

2.2 La transmission mécanique

L'insecte transporte les germes sur ses pattes, son corps, ses pièces buccales ou les élimine par déjections (déchets) et les dépose ou les inocule à un nouvel hôte sans qu'il y ait évolution biologique du germe. C'est le cas du trachome et des infections intestinales qui sont transmis à l'homme par les mouches par l'intermédiaire de ces pattes. Le vecteur peut quelques fois contaminer un milieu, les aliments au lieu de s'attaquer à un être humain..

III METHODES DE LUTTE CONTRE LES RONGEURS

Elle repose essentiellement sur deux méthodes :

- Les méthodes de lutte défensive ;
- Les méthodes de lutte offensive.

3.1 Les méthodes de lutte défensive

Elles reposent sur la disparition des ordures ménagère par le ramassage soigné et quotidien de ces ordures et par leur destruction.

3.2 Les méthodes de lutte offensive

Pour être efficace la lutte doit être intensive, persévérante et étendue car elle comporte beaucoup de limites. L'utilisation des pièges, la lutte biologique par l'emploi de germes microbiens mélangés à un appât, l'utilisation des poisons chimiques s'avèrent inefficaces et dangereux. Seule l'utilisation du chat est d'une grande utilité dans la lutte contre les rongeurs.

IV. SOURCES DE BRUIT :

Les bruits peuvent provenir :

- D'un poste de radio ou télévision ;
- Des appareils ménagers ;
- Des ustensiles de cuisine ;
- Des jeux d'enfants ;
- De la circulation liée à l'intensité du trajet routier, ferroviaire, aérien ;
- Des chantiers et d'usine, etc.

V. EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE

Ils sont plutôt d'ordre fonctionnel. Ils ne peuvent pas aboutir à des lésions organiques de l'appareil auditif. Des bruits déterminent une série de réactions végétales (irritation, malaise, modification du caractère, diminution de l'attention et du rendement).

CONCLUSION :

Le rôle régalien des gouvernants est d'assurer dans l'équité et la justice sociale la santé des populations. Ils ne peuvent assumer ce rôle qu'en prenant des mesures sanitaires et sociales appropriées. Notre environnement physique regorge d'un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer négativement sur la santé. Ces facteurs sont la plupart du temps liés aux comportements humains et de la nature elle-même.

Le rôle de l'agent de santé est d'aider les communautés à rendre son environnement moins nuisible pour la santé en adoptant au quotidien des comportements favorables à la santé.

Soins de Santé Primaires /IEC/CCSC /Plaidoyer /Technique d'animation de groupe

A-GENERALITES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES (SSP)

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de connaître la stratégie des soins de santé primaires.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de :

- 1) Décrire l'histoire des SSP dans le monde, en Afrique et en Côte d'Ivoire
- 2) Décrire les caractéristiques des Soins de Santé Primaires
- 3) Citer le but et deux objectifs généraux des Soins de Santé Primaires.
- 4) Enumérer les huit (08) composantes essentielles des Soins de Santé Primaires.
- 5) Décrire deux (02) principes des Soins de Santé Primaires.
- 6) Situer les SSP dans le système national de santé de la Côte d'Ivoire.

I HISTOIRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES DANS LE MONDE, EN AFRIQUE ET EN CÔTÉ D'IVOIRE

1.1 Dans le monde

1.1.1 La période avant la conférence internationale d'Alma-ATA

La communauté sanitaire internationale a constaté que la situation sanitaire mondiale de centaines de millions d'êtres humains dans le monde était inacceptable, en particulier dans les pays en développement. Plus de la moitié de la population mondiale ne bénéficiaient pas de soins de santé dignes de ce nom. Devant cette situation, une nouvelle approche des soins de santé devrait être envisagée afin de parvenir à l'équité et la justice sociale en matière d'accès aux soins.

1.1.2 A la conférence internationale d'Alma-ATA

Par décision de l'Assemblée de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Conseil d'administration du Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance, 134 pays du sud, 67 organisations des Nations-Unies, institutions spécialisées et organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, se sont réunis du 6 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata et ont adopté la **stratégie des soins de santé primaires** comme nouvelle approche pour réduire les inégalités flagrantes dans l'offre de soins entre les peuples dans le monde

1.2 En Afrique

1.2.1 En 1985.

Les Etats Africains membres de l'organisation mondiale de la santé se sont retrouvés dans la capitale Zambienne (Lusaka) pour dégager trois niveaux d'application des Soins de Santé Primaires. Ceci pour assurer une bonne coordination des activités.

Il s'agit des niveaux périphérique ou primaire, intermédiaire ou secondaire, central ou tertiaire.

Le niveau périphérique est le niveau de mise en œuvre des activités des Soins de Santé Primaires.

Le niveau intermédiaire est le niveau d'appui et de soutien du niveau périphérique ou primaire

Le niveau central est le niveau stratégique ou le niveau politique.

1.2.2 En 1987

Les pays Africains membres de l'OMS qui se sont retrouvés en Zambie en 1985, vont se rencontrer dans la capitale Malienne (Bamako) pour lancer une initiative historique appelée « initiative de Bamako ». Cette réunion avait pour but de booster la mise en œuvre des stratégies des SSP freinée par des difficultés liées au financement des activités, à la qualité des soins qui ne répond pas aux attentes des bénéficiaires, à la faible participation des communautés aux actions de développement communautaire, au manque de médicaments, au manque de ressources humaines et matérielles.

La rencontre de Bamako a donc adopté les résolutions suivantes :

1. Une participation totale, effective et active des communautés aux activités de développement communautaire ;
2. La mise en place dans chaque pays d'un système de recouvrement des coûts des actes de santé, avec une décentralisation effective et une autonomie de gestion au niveau local à travers des structures communautaires (comité de gestion ou COGES) ;
3. L'adoption par les pays d'une politique vigoureuse de médicaments à moindre coût (médicaments génériques) dans leurs politiques de santé.

1.3 En Côte d'Ivoire

1.3.1 En 1981

Adoption de la stratégie des soins de santé primaires par le gouvernement

1.3.2 En 1991

La Côte d'Ivoire s'inscrit pour le démarrage des activités de mise en œuvre des stratégies des soins de santé primaires treize (13) ans après la déclaration d'ALMA-ATA.

1.3.3 En 1993

Démarrage effectif des activités des SSP à la base de secteur de santé rurale de Bouaflé, choisi comme secteur pilote. Le démarrage été précédé par la formation de toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre (médecin, infirmier, Sage-femme, représentant de la communauté, etc.).

1.3.4 En 1994

Création des districts sanitaires en remplacement des bases de secteur de santé rurale par l'arrêté N° 113/MSP/DG-SSS du 02 Juin 1994

Cette nouvelle appellation lui conféra le statut d'unité sanitaire décentralisée regroupant tous les services sanitaires publics et privés tant en milieu urbain que rural. Ils devinrent ainsi le niveau opérationnel du système national de santé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire.

1.3.5 En 1996

Suite à l'évaluation du programme de valorisation des ressources humaines, le gouvernement Ivoirien a adopté le 1^{er} Plan National de Développement Sanitaire (PNDS). De ce plan, la politique du district sanitaire a été réaffirmée et le PMA des niveaux primaire et secondaire a été institué par arrêté N°741/MSP/CAB du 09/12/1996.

1.3.6 En 2002

Le Système National de Santé Ivoirien est réorganisé et restructuré par arrêté N° 028/MSP/CAB du 08 février 2002 portant détermination de la pyramide sanitaire et répartition des établissements et services publics sanitaires. Deux versants (versant prestataire et gestionnaire) font leur apparition pour séparer les activités de prestation de celles de gestion. Le versant prestataire comporte les structures de prestation de soins (ESPC...) et le versant gestionnaire les structures de gestion (District sanitaire...)

II- CARACTERISTIQUES DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES.

Les SSP sont :

2.1 Des soins essentiels : c'est-à-dire des soins qui doivent répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain.

2.2 Des soins accessibles : c'est-à-dire des soins qui doivent être mis à la portée de tous, tant au plan géographique, social, financier que culturel.

2.3 Des soins adaptés : c'est-à-dire des soins qui doivent être techniquement applicables et socialement acceptables, et conforme aux besoins de santé des populations et aux ressources du milieu.

2.4 Soins intégrés : c'est-à-dire des soins qui ne constituant pas une entité indépendante mais élément du système national de santé et intimement liés aux autres secteurs socio-économiques qui contribuent au développement (industrie, éducation, agriculture, urbanisme, etc.).

III. BUT ET OBJECTIFS GENERAUX DES SSP EN COTE D'IVOIRE

3.1. But

Améliorer les conditions socio-sanitaires des populations ivoiriennes avec un accent particulier sur la santé de la mère et de l'enfant.

3.2. Les objectifs généraux

- Réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles par la promotion de la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre du développement des soins de santé primaires et d'une approche multisectorielle ;
- Mettre en place un système de prestations sanitaires qui réponde de façon plus efficace aux besoins prioritaires de santé de la majorité de la population ;
- Etablir la base d'une politique axée sur la participation communautaire qui garantisse la mise en œuvre, et la pérennisation d'un système de financement communautaire

IV. LES COMPOSANTES ESSENTIELLES DES SSP

4.1 Composantes promotionnelles

1. Education appropriée pour la santé en relation avec les problèmes de santé auxquels la population est confrontée.
2. Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles.
3. Approvisionnement suffisant en eau saine ou potable et des mesures d'assainissement de base.

4.2 Composantes préventives

4. Protection maternelle et infantile y compris la santé de la reproduction et la planification familiale.
5. Vaccination contre les principales maladies infectieuses.
6. Prévention et la lutte contre les endémies locales.

4.3 Composantes curatives

7. Traitement des maladies et lésions courantes.
8. Fourniture en médicaments essentiels (modernes et traditionnels)

V. PRINCIPES DE BASE DES SSP

Dans le Rapport mondial sur la santé dans le monde de 2017, l'OMS propose que les pays prennent leurs décisions en matière de systèmes de santé et de développement sanitaire sur la base de quatre grandes orientations étroitement interconnectées.

Ce sont les quatre principes de base des soins de santé primaires. Ils se résument autour de

5.1. La couverture universelle.

Pour que les systèmes de santé soient justes et efficaces, tout le monde doit avoir accès aux soins de santé selon ses besoins et indépendamment de sa capacité de payer. Si ce n'est pas le cas, les inégalités en matière de santé se traduiront par des décennies de différence d'espérance de vie, non seulement entre les pays mais à l'intérieur des pays eux-mêmes.

5.2. Des services centrés sur la personne

Les systèmes de santé peuvent être réorientés afin de mieux répondre aux besoins de la population par l'intermédiaire de points de prestation ancrés dans la collectivité (case de santé par exemple).

5.3 Des politiques publiques saines

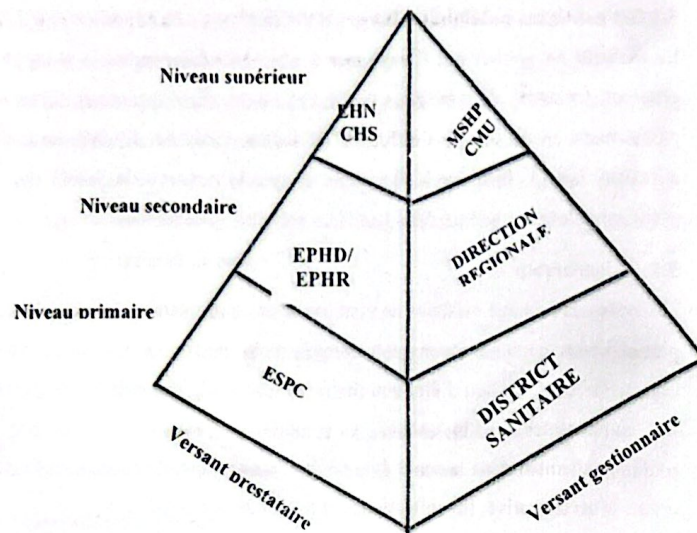
La biologie ne permet pas d'expliquer à elle seule les nombreux écarts de longévité observés. En vérité, de nombreux facteurs ayant des répercussions sur la santé se situent globalement en dehors de l'influence du secteur sanitaire. L'OMS estime que toutes devraient faire l'objet de délibérations et que le concept de "santé dans toutes les politiques" doit être intégré dans toutes les activités gouvernementales.

5.4. Le leadership

Les systèmes de santé existants ne vont pas se muer spontanément en modèles plus justes, plus efficaces (ceux qui fonctionnent mieux) et plus performants (ceux qui atteignent leurs objectifs). Ainsi, au lieu d'être autoritaire, le leadership doit négocier et orienter. Toutes les composantes de la société y compris celles qui ne sont pas impliquées traditionnellement dans la santé doivent être mises à contribution, notamment la société civile, le secteur privé, les collectivités et le monde des affaires.

VI. PLACE DES SSP DANS LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE

Les activités des soins de santé primaires se situent au niveau périphérique ou primaire (voire schéma de la pyramide sanitaire ci-dessous).



SCHEMA DE LA PYRAMIDE SANITAIRE IVOIRIENNE

B-LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL DE COMPORTEMENT

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de conduire une séance CCSC

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant de la licence 1 doit être capable de

- 1) Définir les termes liés au CCSC
- 2) Citer les buts du CCSC
- 3) Citer les principes de base de la CCSC
- 4) Etablir la différence entre les différents concepts utilisés en communication
- 5) Décrire les éléments constitutifs de la communication
- 6) Citer les obstacles à la communication
- 7) Citer les facteurs susceptibles d'influencer le changement social de comportement
- 8) Citer les populations cibles de la CCSC
- 9) Décrire les étapes de la conduite d'une séance de CCSC

INTRODUCTION

La communication pour le changement de comportement (CCC), désormais appelée communication pour le changement social de comportement (CCSC) est une stratégie utilisée en santé publique pour opérer un changement profond de comportement favorable à la santé chez l'individu, la famille ou la collectivité. C'est un gage de la réussite de la mission que la société nous a confiée au personnel de santé et qui consiste à assurer le bien-être de la population.

I. DEFINITIONS

1.1. Communication

C'est un processus dynamique qui permet d'assurer l'apprentissage des gestes à faire et permettre l'ancrage définitif du comportement recherché

1.2. Comportement

C'est l'ensemble des manières de faire ou de pratiques propres à un individu ou à groupe d'individus (Exemple : le refus d'adopter une méthode contraceptive).

1.3. Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC)

Auparavant appelée « communication pour le changement comportemental » (CCC), la CCSC est une approche nouvelle qui favorise et facilite les changements dans les connaissances, les attitudes, les normes, les croyances et les comportements.

II. BUT DE LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL

Elle a pour but de permettre aux :

- Personnes de communiquer ou interagir avec les autres dans un cadre social ;
- Minorités d'être entendues.

III PRINCIPES DE BASE DE LA COMMUNICATION SOCIALE ET COMPORTEMENTALE

Elle se base sur :

- Les valeurs humaines et citoyennes,
- La solidarité
- Le partage.

IV. DIFFERENCE ENTRE LES CONCEPTS UTILISES EN COMMUNICATION

Concepts	Pop cible	Buts	Résultats attendus	Responsable
IEC/CCSC	Individu Communauté Société	Améliorer le bien-être de l'individu, de la communauté et de la société.	Le bien-être de l'individu, de la communauté est amélioré.	Agent de santé ONG de santé
Plaidoyer	Décideurs Politiques	Influencer le changement de politique	Le changement de politique a lieu	Agent de santé Communauté ONG
Mobilisation sociale	La société civile	Réaliser un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous	Le but social commun à travers les efforts et les contributions de tous est réalisé	Agent de santé Communauté Société
Mobilisation communautaire	Groupe cible de la Population	Définir et exprimer ses besoins et objectifs du groupe cible, en prenant des mesures collectives visant à les satisfaire	Les besoins et objectifs du groupe cible sont définis et exprimés	ONG OBC Agent de santé

V. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMMUNICATION

5.1. L'émetteur

C'est celui qui émet le message, c'est la source.

5.2. Le récepteur

C'est celui qui reçoit le message.

5.3. Le message

C'est le contenu de la communication. Il peut prendre plusieurs formes dans le processus de communication. Il peut être gestuel, verbal, dansé, écrit, chanté. Il peut relever du paralangage tels que :

- Les mimiques du visage ;
- Les regards ;
- La façon de se tenir ;
- La tenue vestimentaire.

5.4. Le canal

C'est le moyen de transmission (support physique)

5.5. Le feed-back ou rétroaction

C'est la réaction du récepteur du message vers l'émetteur ou le retour de l'information à l'émetteur.

5.6. Le codage

C'est un ensemble de signes et de règles de combinaison de ces signes. Il permet de constituer et de comprendre des messages. L'émetteur y puise pour constituer son message (*encodage*). Le destinataire identifiera ce système de signes (*décodage*) si son répertoire est commun avec celui de l'émetteur.

VI. LES OBSTACLES A LA COMMUNICATION

6.1. Obstacles liés à l'émetteur

- Non maîtrise du sujet ;
- Mauvais accueil ;
- Non-respect des autres ;
- Etc.

6.2. Obstacles liés au récepteur

- Refus de message ;
- Mauvaise perception du message ;
- Méfiance ;
- Etc.

6.3 Obstacles liés au canal

- Canal indirect ;
- Canal inadapté.

6.4. Obstacles liés au message

- Message confus et imprécis ;
- Message compliqué ;
- Message inapproprié ;
- Etc.

VII. LES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER LE CHANGEMENT SOCIAL DE COMPOTEMENT

Ils sont internes et externes

7.1 Les facteurs internes

7.1.1 Les caractéristiques personnelles et psychologiques

Elles conditionnent le comportement de l'individu, influencent directement ses décisions.

Nous avons : l'âge, le sexe, le niveau d'instruction, l'état matrimonial, etc.

7.1.2 Les connaissances

Ce sont un ensemble d'informations dont dispose l'individu à propos d'un sujet quelconque. Elles constituent un préalable à tout changement de comportement individuel et est l'étape première de la prise de conscience d'un phénomène.

7.1.3 La perception

C'est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d'informations externes pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure.

7.1.4 Les croyances

Ce sont les éléments de connaissances descriptives qu'un individu entretient à l'égard d'un objet.

7.1.5 Les attitudes

Ce sont les réactions émotionnelles et les prédispositions à agir. C'est aussi une orientation que l'on se donne vis-à-vis d'un objet ou d'une idée.

7.2 Les facteurs externes ou environnementaux

7.2.1 La culture

C'est l'ensemble des normes, rites valeurs, convictions et habitudes d'une société dont nous devons tenir compte dans le processus de changement de comportement des individus, communautés ou de la société.

7.2.2 Le milieu social

Toute société met en place un système de stratification des différentes classes sociales qui sont représentées par des groupes homogènes dont les membres partagent le même système de valeurs, de mode de vie, d'intérêts et de comportements (les jeunes, les femmes, les personnes âgées etc.).

VIII. POPULATIONS CIBLES DE LA CCSC

8.1 La population cible primaire

C'est la personne ou groupe de personnes qui doivent changer de comportement pour que le programme atteigne son objectif

Exemple : Les femmes enceintes pour l'amélioration du taux d'accouchement assisté

8.2 La population cible secondaire

Elle est constituée par les personnes qui exercent une influence sur les décisions de la population cible primaire à propos du comportement visé par le projet.

Exemple : Les époux des femmes enceintes

8.3 La population cible tertiaire

Ce sont les décideurs, les financiers et autres personnes ou institutions pouvant aider à l'atteinte des objectifs d'un programme.

Exemple : Le Ministère en charge de la santé.

IX. ETAPES DE LA CONDUITE D'UNE SEANCE DE CCSC

9.1 Avant la séance de CCSC

Un certain nombre de questions doit précéder la conduite d'une séance CCSC :

Quoi ? (Sur quel thème porte la communication ?)

Pourquoi ? (Quels sont ses objectifs ?)

A qui ? (Auprès de quelles cibles ?)

Combien ? (Quelles sont les ressources financières, humaines, matérielles à mobiliser)

Comment ? (Quels sont les moyens adaptés à chaque cible ?)

Quand ? : quel est le planning de mise en œuvre ?

Qui ? : Qui véhicule le message ?

9.2 La séance de CCSC proprement dite (étapes à suivre)

Les étapes à suivre pour conduire une séance de CCSC

1^{ère} étape : Analyser la situation pour identifier du problème ;

2^{ème} étape : Fixer les objectifs ;

3^{ème} étape : Identifier les populations bénéficiaires ;

4^{ème} étape : Identifier les ressources (financières, humaines et matérielles) ;

5^{ème} étape : Identifier les stratégies (méthodes) ;

6^{ème} étape : Mettre en place un plan d'action (planification) ;

7^{ème} étape : Mettre en œuvre un plan d'action (Exécution) ;

8^{ème} étape : Faire le suivi et l'évaluation des stratégies.

CONCLUSION

En tant que futurs acteurs du changement, vous avez la responsabilité de maîtriser les principes et les pratiques de la CCSC, de développer des compétences en communication interculturelle et de promouvoir une communication éthique et responsable.

la CCSC constitue donc pour vous un investissement essentiel pour l'avenir de nos sociétés.

En vous appropriant le cours, vous contribuerez à construire un monde où chacun aura la possibilité de s'épanouir et de participer pleinement à la vie sociale.

C/ PLAIDOYER

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de conduire un plaidoyer en santé

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, l'étudiant de la L1 doit être capable de :

- 1) Définir le plaidoyer en santé
- 2) Citer les buts du le plaidoyer en santé
- 3) Décrire les éléments clés d'un plaidoyer en santé
- 4) Enumérez l'importance du plaidoyer
- 5) Citer la population cible du plaidoyer
- 6) Enumérer les étapes de la conduite d'un plaidoyer

INTRODUCTION

Dans le cadre de la santé, le plaidoyer revêt une importance cruciale. Il s'agit d'un ensemble d'actions stratégiques visant à influencer les décisions et les politiques afin d'améliorer la santé des populations. Il constitue un outil puissant pour promouvoir la santé et le bien-être des populations. Il permet de faire entendre les voix des personnes concernées et d'influencer les décisions qui ont un impact sur leur santé.

I. DEFINITION DU PLAIDOYER EN SANTE :

Le plaidoyer dans le domaine de la santé est un processus actif qui consiste à influencer les décideurs politiques, les professionnels de la santé, les organisations et le public en général, afin de promouvoir des politiques, des programmes et des pratiques favorables à la santé.

II. BUTS DU PLAIDOYER

Le plaidoyer vise à :

- Améliorer l'accès aux soins de santé.
- Promouvoir la prévention des maladies.
- Réduire les inégalités en matière de santé.
- Renforcer les systèmes de santé.
- Sensibiliser aux enjeux de santé publique.

III. IMPORTANCE DU PLAIDOYER DANS LE DOMAINE DE SANTE :

- Obtenir un engagement politique et des ressources financières pour les programmes de santé.
- Promouvoir des changements de comportement favorables à la santé.
- Lutter contre les discriminations et les inégalités en matière de santé.
- Renforcer les droits des patients.

IV. ÉLÉMENTS CLES DU PLAIDOYER EN SANTE :

Influence des décideurs :

Le plaidoyer en santé cherche à influencer les décideurs politiques à tous les niveaux (local, national, international) pour qu'ils adoptent des politiques et des lois favorables à la santé.

Mobilisation de la communauté :

Il implique souvent la mobilisation des communautés, des organisations de la société civile et des professionnels de la santé pour faire entendre leur voix.

Communication stratégique :

Le plaidoyer en santé repose sur une communication efficace et ciblée, utilisant divers canaux (médias, réseaux sociaux, événements, etc.) pour sensibiliser et persuader.

Données probantes :

Il s'appuie sur des données probantes et des recherches scientifiques pour étayer les arguments et les recommandations.

V. POPULATIONS CIBLE DU PLAIDOYER

- Décideurs politiques
- Organisations civiles nationales et internationales, etc.

VI. ÉTAPES DE LA CONDUITE D'UN PLAIDOYER

6.1 Avant le plaidoyer

Le questionnement qui précède toute stratégie de plaidoyer est le suivant :

Quel est le problème ?

Pourquoi le décideur devrait-il se préoccuper de ce problème ?

Quelle est la solution proposée ?

Quel est son impact probable sur le problème ?

6.2 Étapes d'une stratégie de plaidoyer

Il existe neuf (09) étapes dans une stratégie de plaidoyer :

1^{ère} étape : Identifier le thème sur lequel doit porter le plaidoyer ;

2^{ème} étape : Énoncer le but du plaidoyer ;

3^{ème} étape : Identifier les décideurs et personnes influentes ;

4^{ème} étape : Identifier les centres d'intérêts majeurs des décideurs ;

5^{ème} étape : Identifier les oppositions et obstacles possibles au plaidoyer ;

6^{ème} étape : Identifier les atouts et lacunes du plaidoyer ;

7^{ème} étape : Choisir les partenaires du plaidoyer ;

8^{ème} étape : Identifier les techniques à utiliser pendant le plaidoyer ;

9^{ème} étape : Les messages pour le plaidoyer.

CONCLUSION

En tant que futurs professionnels de la santé, vous avez la responsabilité de devenir des acteurs de changement, capables de mener des actions de plaidoyer efficaces et pertinentes. Vous devez vous engager à défendre les intérêts des patients, à promouvoir la santé publique et à contribuer à la construction de systèmes de santé plus justes et plus durables. Le plaidoyer en santé constitue pour vous un outil puissant pour transformer les systèmes de santé et améliorer la vie des populations. En maîtrisant les techniques et les stratégies de plaidoyer, vous pouvez devenir des agents de changement et contribuer à la construction d'un monde où la santé est un droit pour tous.

CONCLUSION GÉNÉRALE

LA CCSC et le plaidoyer sont un processus complexe qui nécessite une préparation minutieuse. Tout changement social de comportement est lent et ne se fait pas à coup de bâton magique. Il en est de même pour toute prise de décision ou de changement de politique. Il est donc nécessaire de prendre du temps dans leur préparation. L'infirmier et la sage-femme doivent s'y préparer afin d'éviter l'improvisation au risque de déstabiliser l'environnement culturel des populations bénéficiaires.

D/ TECHNIQUE D'ANIMATION DE GROUPE

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L1 de conduire une séance d'animation de groupe.

Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Citer les différentes fonctions d'un animateur de groupe
- 2) Enoncer les attitudes d'un animateur de groupe
- 3) Citer les qualités d'un bon animateur de groupe
- 4) Enumérer la taxonomie de la technique d'animation de groupe.
- 5) Décrire les cinq (5) techniques d'animation de groupe
- 6) Décrire les techniques de gestion de conflits pendant l'animation de groupe
- 7) Enumérer les attitudes à adopter pendant la gestion d'un conflit

INTRODUCTION

Les techniques d'animation de groupe sont des stratégies qui participent au changement social de comportement de la population. Plusieurs techniques existent pour faire l'animation d'un groupe. Ainsi, le choix d'une technique d'animation est lié aux objectifs visés par le thème. Chaque technique peut être adaptée aux besoins spécifiques du groupe et au thème abordé. L'animateur doit se sentir à l'aise dans la technique qu'il a choisie librement d'utiliser. L'infirmier et la sage-femme, dans la stratégie de changement social de comportement doit s'approprier ces différentes techniques d'animation afin d'opérer ce changement

I. FONCTIONS D'UN ANIMATEUR DE GROUPE

1.1 La fonction de production

Elle signifie que l'animateur doit produire un résultat, trouver une solution ou des éléments de solution en développant une stratégie qui permette d'atteindre les objectifs fixés.

1.2 La fonction de facilitation

Cette fonction signifie que l'animateur doit organiser (suggérer un plan de travail par exemple) et clarifier (faire définir les mots employés) le travail du groupe.

1.3 La fonction de régulation

Cette fonction qui concerne les relations entre les participants signifie que l'animateur doit maintenir le groupe uni dans un climat détendu en évitant ou résolvant les conflits (faire diversion en plaisantant par exemple).

II. LES ATTITUDES D'UN ANIMATEUR DE GROUPE

L'animateur doit être :

- Un bon organisateur ;
- Au parfum de son sujet ;
- Accueillant, poli, courtois, respectueux, impartial ;
- Exemple ;
- Humble et expliquer les mots techniques ? etc.

III. LES QUALITES D'UN BON ANIMATEUR

L'animateur doit :

- Accepter d'être « sous le regard » des participants ;
- Eviter de monopoliser la parole au détriment des participants ;
- Eviter d'avoir un débit de langage trop rapide et pouvoir ménager des pauses dans la chaîne parlée ;
- Eviter de rester en seul lieu en alternant stationnements et déplacements ;
- Mettre en mouvement le groupe vers les objectifs fixés ;
- Prendre la bonne distance et faire les interventions debout, ce qui permet de se déplacer et créer un ascendant sur les participants, etc.

IV LA TAXONOMIE DE LA TECHNIQUE D'ANIMATION DE GROUPE

Toute animation de groupe doit obéir à l'ordre suivant

1. Saluer les participants et se présenter ;
2. Demander au participant de se présenter (si possible) ;
3. Commencer l'animation dès l'entrée en salle ;
4. Introduire le thème de façon vivante ;
5. Animer dans la langue connue de tous ;
6. Eviter si possible les interprètes (déperdition

V. QUELQUES TECHNIQUES D'ANIMATION DE GROUPE

5.1 L'EXPOSE : il favorise l'expression

Définir l'objectif	- Formuler l'objectif en fonction du résultat à atteindre. - L'objectif général peut se décliner en objectifs spécifiques précis, réalisables, concrets, avec utilisation des verbes d'action
Choisir l'angle et délimiter le contenu	Définir l'information en fonction de l'aspect du sujet qui sera mis en lumière à partir de l'objectif visé, mais aussi en fonction de l'auditoire.
Déterminer le message essentiel	- Le contenu de l'exposé est toujours ciblé. Il est déterminé par l'objectif visé, mais aussi par le public. - Il est donc important de cerner les caractéristiques de ce public particulier pour adapter le contenu de l'intervention. - Le message essentiel doit permettre d'articuler les idées et d'organiser le contenu de notre intervention.
Organiser le contenu	Un exposé se structure en trois parties : - Introduction ; - Développement ; - Conclusion. Il faut intégrer le timing Dans l'introduction - Se présenter ; - Préciser le contexte global dans lequel s'inscrit l'intervention ; - Enoncer le message essentiel ; - Présenter les objectifs et définir le temps (durée). Dans le développement - Présenter une structure logique suivant un plan chronologique, un plan thématique. Dans la conclusion - Faire une synthèse ; - Reprendre le message essentiel.
Rédiger des notes	- Réaliser un aide-mémoire avec de petites cartes ; - Cartes aérées pour pouvoir s'y repérer rapidement et maintenir le contact avec l'auditoire ; - Rédiger ses notes d'un seul côté et les numéroter clairement afin d'éviter de s'embrouiller.
Prévoir des supports	- Le papier Padex et le Padex ; - Le vidéo projecteur - Le vidéo projecteur

5.2 LE BRAINSTORMING OU REMUE-MENINGES

Objectifs	- Produire en groupe un maximum d'idées sur un sujet donné - Découvrir des représentations - Faire surgir des questions ou réflexions
Consignes et déroulement	Le facilitateur - Introduit le sujet à traiter et esquisse les objectifs attendus du brainstorming. - Pose une question ouverte sur le sujet à traiter (par exemple : qu'est-ce que la santé ?) - Note sur grand papier toutes les idées ressorties, en s'efforçant de les regrouper mentalement ou graphiquement, par thème ou idées plus générales. - Demande au groupe de revenir sur la matière générée et reformuler les idées floues et se mettre d'accord sur les grandes thématiques abordées. - Invite les participants à se mettre en petits groupes pour discuter et reformuler les idées floues ressorties.
Durée estimée	Le brainstorming doit se terminer dès que les participants sont à court d'idées.
Matériel nécessaire	- Padex et papiers Padex - Marqueurs effaçables
Public cible	- Tout public adulte ; - Groupe de moins de 15 personnes.
Contexte d'utilisation	Cette technique est utilisée dans - Les réunions, les ateliers participatifs de formation et les groupes de discussion - Les réunions du personnel de santé (réunions d'information, de prise de décision, de plaidoyer, etc.). - la formation du personnel des centres de santé et des agents de santé communautaire ...
Points forts	- Rapide et facile à organiser ; - Augmente la capacité de créativité ; - Favorise l'esprit de groupe ; - Les participants s'approprient les résultats.
Mises en garde	- Une mauvaise animation peut conduire les participants à hésiter de s'exprimer ; - Le facilitateur ne doit pas faire paraître ses idées personnelles.

5.3 JEUX DE ROLES

Objectifs	- Prendre conscience de ses attitudes dans des situations professionnelles ; - Prendre consciences des éléments verbaux et non verbaux de la communication ; - Analyser une situation dans sa complexité ; - Comprendre le point de vue d'autrui.
Consignes et déroulement	- Le facilitateur doit être conforme à l'objectif qu'il propose au groupe. - il s'agit d'un jeu de rôles qui permet une analyse des pratiques ou une analyse de cas. - Sur proposition du facilitateur qui a préparé une fiche de jeu de rôles ou de groupe, il est décidé de jouer une scène qui sera objet d'analyse. - Le facilitateur invite le groupe à se répartir en trois petits groupes pour mettre en scène le jeu de rôles et le troisième petit groupe se charge de regarder en silence les scènes et d'en faire des observations. - Après 20 à 30 min de préparation de jeu de rôles en petits groupes, le facilitateur demande aux petits groupes de mettre en scène le jeu de rôles en plénière. - Il demande en suite aux acteurs et puis aux observateurs d'exprimer ce qu'ils ont ressenti en mettant en scène le jeu. - Le facilitateur invite vers la fin les participants à analyser le sujet mis en situation.
Matériel nécessaire	- Padex et papier Padex - Marqueurs pour noter les éléments d'analyse de la situation et les recommandations
Public cible	Tout public adulte
Contexte d'utilisation	Cette technique est plus utilisée dans : - Les ateliers participatifs de formation le groupe de discussion : - La formation du personnel de santé sur des thèmes liés à la santé ; - Les groupes de discussion avec le personnel de santé. - L'analyse, la production, l'argumentation, la synthétisation et l'établissement d'un consensus autour d'un sujet
Points forts	Les participants vivent les situations et les analysent, ce qui leur favorise la prise de conscience et la remise en question.
Mises en garde	- Faire attention à la répartition des rôles à jouer au sein des petits groupes. - Technique peut être difficile pour certaines personnes, surtout lorsque le rôle que la personne doit jouer correspond à sa profession. - Prévoir si c'est possible, une co-animation pour le jeu de rôles, - Il peut avoir un animateur qui soit attentif aux questions et un autre attentif aux émotions.

5.4 ETUDE DE CAS

Objectifs	Analyser et apprendre à résoudre les problèmes posés en groupe
Consignes et déroulement	- Le facilitateur invite les participants à se mettre en petits groupes pour répondre aux questions à ces questions : - Quel est le problème posé par le cas ? - Quelles sont les causes et les conséquences de ce problème - Quelles sont les solutions possibles au problème posé ? - Après 30 min de travail en petits groupes, le facilitateur demande aux rapporteurs des petits groupes, en fonction du temps de restituer les travaux de petits groupes. - Le facilitateur évoque une discussion en plénière sur le problème posé dans le cas où la situation, ses causes, ses conséquences et les solutions possibles proposées par les petits groupes.
Matériel nécessaire	- Padex et papier Padex - Marqueurs effaçables pour noter le problème identifié, son niveau, ses causes, ses conséquences, les personnes impliquées dans le problème et les solutions possibles.
Public cible	Tout public adulte
Contexte d'utilisation	- Cette technique est plus utilisée dans : - Les ateliers participatifs de formation - Les groupes de discussion sur des thèmes liés à la santé pendant la formation du personnel de santé - Les groupes de discussion avec le personnel de santé. - L'analyse, la production, l'argumentation, la synthétisation et L'établissement d'un consensus autour d'un sujet
Point fort	Une technique rigoureuse qui favorise l'implication de tout le monde dans l'analyse.
Mises en garde	Le choix de la situation fait des participants des personnes responsables du problème.

5.5 LA PRESENTATION EN DUO OU TRIO

Objectif	Favoriser les conditions d'expression et du travail en groupe
Consignes et déroulement	- Le facilitateur donne la consigne : - Demande aux participants de constituer des duos ou des trios avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont découvrir. - Dans les duos ou trios, chaque participant est invité à se présenter, (prénom, motivations, valeurs, qualités et souvenirs) à son collègue ou à ses collègues. - Chaque participant est invité à présenter son collègue en plénière, (dessin, parole, mime, etc.) - Après échange en trios, chaque participant présente son collègue au groupe, en plénière.
Matériel nécessaire	Papier et stylos
Contexte d'utilisation	Pendant la formation et dans un groupe de discussion.
Points forts	Facilite le travail en groupe
Mise en garde	Certains animateurs rencontreraient des difficultés pour présenter les collègues de sexe opposé.

VI. TECHNIQUES DE GESTION DE CONFLITS PENDANT L'ANIMATION DE GROUPE

6.1. Définition

La gestion des conflits est la capacité à **anticiper, reconnaître, prévenir et résoudre** les tensions efficacement. C'est aussi faire preuve d'humilité et de psychologie, afin de désamorcer certaines frustrations au sein d'un groupe

6.2. Comprendre la nature des conflits dans l'animation de groupe

6.2.1. Sources des conflits

✓ Différences de Personnalité et de Style :

Les groupes sont souvent composés de personnes issues de milieux divers, avec des personnalités et des approches de travail variées. Ces différences, si elles ne sont pas reconnues et respectées, peuvent facilement conduire à des tensions.

✓ Manque de Communication

La communication est le pilier d'une collaboration efficace. Une information mal transmise, une décision non partagée ou un feedback mal interprété peuvent rapidement

dégénérer en conflit. Souvent, ce ne sont pas les divergences d'opinion qui posent problème, mais la manière dont elles sont exprimées et reçues.

✓ Pression de Travail et Stress

Les membres du groupe sont souvent sous pression, surtout en période d'activités intenses. Le stress peut amplifier les petites frictions et faire exploser les tensions latentes. Lorsque la fatigue s'accumule, la patience diminue, et des conflits qui auraient pu être évités ou résolus facilement deviennent des obstacles majeurs.

✓ Conflits de Rôle et d'Autorité

Dans un groupe, les rôles et les responsabilités ne sont pas toujours clairement définis. Qui est responsable de quoi ? Qui a la dernière décision dans telle ou telle situation ? L'ambiguïté autour des rôles peut entraîner des frustrations et des conflits, surtout si certains membres de l'équipe sentent que leurs efforts ne sont pas reconnus ou que leur autorité est remise en question.

6.2.2 Les Conséquences des Conflits Mal Gérés

✓ Détérioration de l'Atmosphère de Travail

Un conflit non résolu peut rapidement contaminer l'atmosphère de travail. Ce qui était autrefois un environnement collaboratif et joyeux peut devenir tendu et hostile. Les membres de l'équipe commencent à éviter les uns les autres, les communications deviennent limitées, et la coopération diminue.

✓ Impact sur la Performance de l'Équipe

Le manque de cohésion dans une équipe se traduit par une baisse de la performance. Une équipe désunie est incapable d'offrir le niveau de qualité attendu.

✓ Turnover et Absence de Motivation

Lorsqu'un conflit persiste, il peut pousser certains membres de l'équipe à quitter l'organisation. De plus, la motivation des membres restants diminue, affectant leur engagement et leur passion pour le travail.

6.3. Techniques avancées pour gérer les conflits

6.3.1 Prévention des Conflits

✓ Encourager une communication ouverte

La communication est la clé pour éviter les malentendus. Créer un environnement où chaque membre de l'équipe se sent à l'aise de partager ses pensées et ses préoccupations.

Cela passe par l'utilisation d'outils de communication clairs et accessibles, et la promotion d'une écoute active.

✓ **Établir des rôles et des responsabilités clairs**

Définir dès le début, qui fait quoi ? Chaque membre de l'équipe doit savoir ce qui est attendu de lui, quelles sont ses responsabilités, et à qui il doit rendre des comptes. En clarifiant ces aspects, on réduit les zones de friction et on favorise une meilleure collaboration.

✓ **Promouvoir l'Intelligence Émotionnelle**

La capacité à comprendre et gérer ses propres émotions, tout en étant sensible à celles des autres. Dans un environnement d'animation, où les interactions sociales sont nombreuses et intenses, développer cette compétence peut être un atout majeur pour prévenir les conflits.

6.3.2 Gestion du conflit

6.3.2.1 Avant la gestion du conflit

Les conflits dans un groupe de personnes sont normaux et inévitables. Le groupe ne peut pas progresser sans qu'il y ait des oppositions et des confrontations. Mais avant tout gestion de conflit, il faut :

✓ **Identifier l'origine des conflits**

Il peut provenir soit blocage de l'explosion de la révolte dû à l'impuissance soit la répression par le respect des règles formelles.

✓ **Mesurer l'expression de la tension**

Il peut s'exprimer par la diversion, le bouc émissaire, le conflit de leadership (lutte pour influencer le groupe).

✓ **Mesurer la décharge de la tension**

L'intensité de la tension peut découler d'un :

- Fou-rire général ;
- Ralliement de tous à une solution de fuite ;
- Brouhaha, une agitation générale, etc.

6.3.2.2. Gestion du conflit en direct

✓ **La Médiation Interne**

La médiation est une méthode puissante pour résoudre les conflits en interne, sans avoir besoin de recourir à une intervention extérieure.

Elle consiste à désigner une personne neutre, souvent un chef d'équipe ou un membre respecté de l'équipe, pour écouter les deux parties du conflit, comprendre leurs points de vue, et les aider à trouver un terrain d'entente. Cette approche permet de résoudre le conflit de manière collaborative, en préservant la relation entre les parties impliquées.

✓ **Le Feedback Constructif**

Le feedback est un outil essentiel dans la gestion des conflits. Plutôt que de laisser une situation dégénérer, il est important d'aborder directement les problèmes en fournissant un feedback constructif. Cela signifie exprimer clairement ce qui pose problème, en se concentrant sur les comportements plutôt que sur les personnes, et en proposant des solutions pour aller de l'avant. Cette méthode permet de corriger le tir rapidement et de renforcer la dynamique d'équipe.

✓ **La Réunion de Résolution des Conflits**

Lorsqu'un conflit implique plusieurs membres de l'équipe ou affecte la dynamique globale du groupe, il peut être nécessaire d'organiser une réunion dédiée à sa résolution. Cette réunion doit être bien structurée, avec un ordre du jour clair et une intention de résoudre le problème. Chaque partie doit avoir l'opportunité de s'exprimer, et l'objectif est de trouver une solution qui soit acceptable pour tous. Il est important de finir la réunion sur une note positive, en s'assurant que chacun a bien compris les actions à mettre en place pour résoudre le conflit.

✓ **Les Techniques de Négociation Avancée**

La négociation est souvent nécessaire dans les situations de conflit où les intérêts des parties sont divergents. Savoir négocier efficacement, c'est savoir trouver des compromis qui satisfont les besoins de chacun. Cela peut passer par l'identification des intérêts sous-jacents plutôt que des positions rigides, la recherche de solutions créatives, et la volonté de faire des concessions réciproques. Une négociation bien menée peut transformer un conflit en une opportunité de renforcement des relations au sein de l'équipe.

VII. ATTITUDES DE L'ANIMATEUR DANS LA GESTION D'UN CONFLIT

7.1 Etre transparent dans ses intentions

- Annoncer clairement au groupe les objectifs et les modalités de travail prévues ;
- Ne pas se laisser absorber ou fasciner par le sens immédiat du contenu.

7.2 Etre vigilant et présent intégralement sur ce qui se passe

- Être attentif à un silence qu'à un éclat de voix, à une position des chaises ou à une posture physique,
- Être discrète à une intervention agressive, à la fréquence des apartés qu'à une procédure de vote ;
- Ne pas prendre parti dans un conflit entre les sous-groupes,
- Ne pas se laisser envahir par l'antipathie pour telle personne,
- Ne pas être exaspéré par une manière d'agir du groupe,

7.3 Faire preuve d'empathie et de congruence.

- Etre en empathie permet de percevoir l'état dans lequel est l'autre, sans pour autant se sentir envahi par ses propres émotions ;
- Accepter ce que les personnes éprouvent, tout en conservant une capacité intellectuelle de formulation abstraite et la lucidité nécessaire ;
- Repérer et être clair avec ses représentations du groupe et avec ses attentes vis-à-vis du groupe.

7.4 Ne pas interpréter ce qui se passe

- Ne pas se « projeter » sur le groupe ;
- Ne pas se croire à priori et se sentir personnellement concerné ;
- Éviter les interprétations négatives.

CONCLUSION

Un message bien perçu dans un groupe est lié en grande partie au choix d'une bonne technique d'animation. Il est donc primordial aux futurs agents de santé de maîtriser ses différentes techniques afin de conduire efficacement une séance de de sensibilisation et de mobilisation sociale.